

TUDO O QUE O SISTEMA FAZ

# Nada aqui foi deixado de fora.

Este documento lista **todas** as funções do CRC, uma por uma, sem termo técnico. Ele foi montado a partir do inventário do próprio sistema — não de um resumo — para que nenhuma capacidade ficasse esquecida numa gaveta.

O sistema faz muita coisa. Para não virar uma lista sem fim, ele está organizado pela pergunta que cada parte responde no dia da clínica.

| PARTE                    | A PERGUNTA QUE RESPONDE                      | PÁG.   |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 1 · Atender              | Quem está falando com a gente agora?         | 3      |
| 2 · Captar               | De onde vem o paciente, e quanto ele custa?  | 4      |
| 3 · Encher a agenda      | Como não deixar cadeira vazia?               | 5      |
| 4 · Recuperar            | Onde está o dinheiro que já é nosso?         | 6      |
| 5 · Fechar tratamento    | Por que o orçamento não virou tratamento?    | 7      |
| 6 · Cobrar               | Como cobrar sem perder o paciente?           | 8      |
| 7 · A inteligência       | Como ela decide, quem aprova, e o que custa? | 9 a 11 |
| 8 · Conhecer o paciente  | Com quem eu estou falando?                   | 12     |
| 9 · Gerir                | O que mudou, e onde estamos apertados?       | 13     |
| 10 · Controlar           | Quem manda, e como eu paro tudo?             | 14     |
| 11 · O que ele nunca faz | Onde estão os limites?                       | 15     |
| 12 · Onde estamos        | Quando isso começa a funcionar?              | 16     |
| Mapa                     | Como tudo isso se conecta, numa página só    | 17     |

## Uma coisa antes de começar

Este sistema **não substitui o Dental Office**. Ele trabalha em cima dele: lê o que está lá, percebe o que ninguém teve tempo de perceber, e devolve trabalho pronto para a equipe. Prontuário, faturamento e estoque continuam onde sempre estiveram.

Tudo começa quando alguém escreve. O sistema responde na hora, a qualquer horário — e sabe quando *não* deve responder.

## Responde no WhatsApp

Na hora, inclusive fim de semana e madrugada. Entende se a pessoa quer marcar, remarcar, saber preço ou convênio.

Responde só com o que vocês cadastraram. Não inventa.

## Sabe a hora de chamar gente

Dor, sintoma, remédio, reclamação ou qualquer coisa que exija julgamento clínico: ele para na hora e passa para uma pessoa.

Essa decisão ele toma sozinho, sem consultar configuração nenhuma.

## Uma conversa por pessoa

O mesmo paciente escrevendo de dois números, ou aparecendo com nome diferente, continua sendo uma pessoa só. O sistema junta.

Quando tem dúvida, ele **não** escolhe: marca como ambíguo e pergunta.

## A caixa de entrada da equipe

Quem está esperando resposta, há quanto tempo, e quem assumiu cada conversa. Ninguém responde em cima do outro.

## Entende o horário que a pessoa escolheu

“Pode ser terça de manhã”, “depois das 18h”, “só não pode sexta” — ele interpreta e confere contra a agenda real.

## Respeita a janela do WhatsApp

O WhatsApp só deixa escrever livremente por 24h depois que a pessoa falou. Fora disso, exige mensagem aprovada — e o sistema sabe disso.

Sem essa regra, a mensagem falha em silêncio e ninguém descobre que não chegou.

## Busca tudo numa caixa só

Digite um nome, um telefone ou um pedaço de conversa: ele acha o paciente, o lead, a oportunidade e a conversa de uma vez.

## Fala com a voz da clínica

O nome que aparece para o paciente, o tom e a assinatura são configurados por vocês — e valem para tudo que sai.

A pergunta que quase nenhuma clínica consegue responder é “qual anúncio trouxe paciente de verdade?”. O sistema responde porque acompanha a pessoa do clique até a cadeira.

## Guarda de onde veio

Google, Instagram, qual campanha, qual anúncio. Fica gravado no contato desde o primeiro segundo.

## Não perde a origem no caminho

A pessoa clica, some, e volta dias depois pelo WhatsApp. O sistema reconhece que é a mesma pessoa e mantém a campanha ligada a ela.

Sem isso, toda campanha parece não converter e o crédito vai para “WhatsApp direto”.

## O relógio do primeiro contato

Marca quanto tempo levou até alguém responder, e mostra quantos foram atendidos em até 5 minutos.

Lead que ninguém respondeu fica visível, não escondido na fila.

## Distribui entre a equipe

Cada lead novo ganha um responsável, e o sistema mostra a carga de cada um.

## Custo por etapa

Você lança quanto investiu. Ele divide: custo por lead, por consulta marcada e por **paciente que compareceu**.

O custo por clique engana. O custo por quem sentou na cadeira, não.

## Campanha contra campanha

Quanto cada uma custou, quantos leads trouxe, quantos compareceram, e o custo por paciente — lado a lado.

## Campanhas com cadência

Falar com um grupo sem perder o jeito de falar com uma pessoa: as mensagens saem em levadas, espaçadas, e não num disparo só.

## Testa versões da mensagem

Duas formas de dizer a mesma coisa, e o sistema mede qual funciona — com freio: se uma versão começa a fazer gente sair da lista, ele para aquela versão sozinho.

## A campanha nasce de uma meta, não de uma lista

O erro mais comum é escolher a lista primeiro (“vamos mandar para todo mundo”) e inventar o objetivo depois. Aqui é o contrário: a meta define o público. Meta de ocupação fala com quem não tem retorno marcado; de reativação, com quem sumiu.

Cadeira vazia é o prejuízo mais silencioso de uma clínica: não aparece em relatório nenhum, porque não é uma perda — é uma coisa que simplesmente não aconteceu.

## Percebe o buraco na hora

Cancelou às 14h de quinta? O sistema enxerga a janela aberta — e também os vãos entre duas consultas do mesmo dentista.

## Sabe quem chamar

Da lista de espera, escolhe quem encaixa naquele horário exato: quem pediu aquele dia, aquele turno, aquele dentista.

## Convida de três em três

Com intervalo entre as levas, até quatro levas. Nunca dispara para a lista inteira — senão cinco pessoas aparecem para uma vaga.

## Avisa quem vai faltar

**Antes** de faltar. Estima o risco de cada consulta e diz o motivo: “não confirmou”, “já faltou duas vezes”, “marcou há 3 meses”.

-----  
Risco alto não quer dizer ligar mais: quer dizer deixar o encaixe preparado.

## Confirma a consulta do dia seguinte

E mostra quem ainda não confirmou, para alguém decidir o que fazer.

## Confere a pré-consulta

O que falta para cada consulta acontecer: convênio pendente, documento, autorização. E separa o que a máquina resolve do que precisa de gente.

## Guarda a preferência de cada um

Quem só pode de manhã, quem aceita encaixe de última hora, quem topa outra unidade. Da próxima vez, ele já sabe.

## Oferece horário de verdade

Os horários que ele oferece existem na agenda — não são sugestão genérica que a recepção depois descobre que não cabe.

Toda clínica tem dinheiro parado dentro dela. O sistema chama isso de **Radar de Receita**: ele varre a base procurando o que já foi conquistado e ficou pelo caminho.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Orçamento parado        | Já foi examinado e já ouviu o valor |
| Paciente sumido         | Passou do retorno e ninguém chamou  |
| Faltou e não marcou     | A consulta existiu e não aconteceu  |
| Tratamento interrompido | Começou e parou no meio             |
| Lead sem resposta       | Procurou a clínica e ninguém voltou |

## Calcula a chance, não só o valor

Um orçamento de R\$ 20.000 com 10% de chance vale R\$ 2.000 de expectativa. O sistema mostra o valor **já com a chance dentro**.

É o que impede a lista de ser liderada pelo caso mais caro e mais improvável.

## Ordena por onde vale a pena começar

Mistura valor e urgência. Um caso grande que expira semana que vem vem antes de um maior que pode esperar.

## Decide a próxima ação de cada um

Mandar mensagem, oferecer horários, ligar, pedir um dado, tratar a objeção ou passar para o dentista — com o motivo escrito ao lado.

Ligação só quando o valor em jogo paga os dez minutos de alguém.

## Sabe a hora de desistir

Depois de um número de tentativas sem resposta, ele encerra em vez de insistir. Perder o canal é pior que perder o caso.

## Não repete o que já foi feito

Se alguém da equipe já falou com a pessoa, ou se ela já marcou sozinha, o sistema sai do caminho.

## Mede o que recuperou

Liga a ação do CRC à consulta e à produção que veio depois. É o que separa “mandamos mensagem” de “isso trouxe R\$ 4.000”.

## Potencial e recebido nunca no mesmo número

Enquanto o dinheiro não entrou, ele escreve **potencial** — e não conta como receita. Você nunca vai olhar um número dele e descobrir, semanas depois, que era estimativa. É a diferença entre um painel que ajuda a decidir e um que serve para impressionar.

Quem pediu orçamento já veio à clínica, já foi examinado e já ouviu um valor. É o paciente mais próximo de fechar que existe — e o que mais se perde por falta de acompanhamento.

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Apresentado          | Aguardando a primeira reação                   |
| Está pensando        | Ainda pode fechar — e o tempo conta contra     |
| Achou caro           | Parcelamento, prioridade, tratamento por etapa |
| Tem medo             | Conversa com o dentista — nunca desconto       |
| Falta de tempo       | Horário alternativo, sessões mais curtas       |
| Vai falar com alguém | Material para levar à conversa                 |
| Questão de convênio  | O único que bloqueia o atendimento             |
| Parou de responder   | Etapa própria — não é “perdido”                |
| Aceitou              | E o sistema cobra o ager                       |

## O motivo real, com a frase original

Sete categorias de objeção, sempre com o texto que a pessoa escreveu ao lado. Ninguém precisa confiar na classificação — dá para ler e discordar.

## Aceito e não marcado é alarme

É o pior lugar para um orçamento parar: a pessoa já disse sim e ninguém marcou. Isso fica separado de “aceito e agendado”.

## Importa os orçamentos por planilha

Com prévia antes de gravar: o que vai entrar, o que vai ser atualizado e o que ele não entendeu — linha por linha.

## Mostra onde o funil trava

Qual objeção mais aparece, em qual etapa se perde mais gente, e quanto dinheiro está parado em cada uma.

Cobrança é o assunto que mais estraga relação de clínica. O sistema trata isso com mais freios do que qualquer outra coisa que ele faz.

## Entra pelo que vocês já têm

A lista vem de planilha ou do financeiro. Antes de importar, ele mostra uma prévia: quantos entram, quantos atualizam, e o que não entendeu.

Nada entra às cegas.

## Avisa antes, não só depois

Três dias antes de vencer. Aviso antes do vencimento é lembrete; depois, é cobrança — e a diferença muda a conversa inteira.

## Entende a resposta

Quem diz “já fiz o pix” para a cobrança **na hora** e vira tarefa urgente de conferência — porque o arquivo do financeiro chega com um ou dois dias de atraso, e frequentemente é verdade.

## Quem pede para negociar sai da automação

“Consigo parcelar?” encerra o automático naquele paciente e abre tarefa para alguém. Insistir com quem já pediu para conversar é constrangimento.

## Acordo e parcelamento ficam gravados

Com as datas, e com o nome de quem negociou. Pagou, dá baixa.

## A equipe entrou, o automático sai

No instante em que alguém assume a negociação, a automação para naquele paciente. Ninguém recebe cobrança automática no meio de uma conversa com a recepção.

## Não esquece quem saiu da automação

Quando o limite de tentativas é atingido, vira **tarefa** em vez de sumir. A dívida não desaparece só porque a máquina não pode mais falar.

## Devedor continua sendo paciente

Dívida em aberto não bloqueia atendimento por conta própria. Só convênio pendente bloqueia — e isso é regra da clínica, não decisão da máquina.

## O limite que evita o constrangimento

Cobrança respeita o mesmo teto de contatos, o mesmo intervalo mínimo e o mesmo horário comercial de qualquer outra mensagem. Ninguém recebe cobrança de madrugada nem três avisos no mesmo dia. E quem pediu para não ser contatado não recebe nem cobrança.

Esta é a parte que mais assusta e a que tem mais freio. Vale começar pelo que ela **não** é: não é um robô solto respondendo o que quiser. É um funcionário novo, com manual escrito pela clínica, sob supervisão, e com ordem de chamar alguém quando o assunto passar do ponto.

## Responde com o que a clínica escreveu

Ela não inventa: procura no material da própria clínica — preços, convênios, horários, endereço, como funciona cada tratamento.

O texto é cortado em pedaços que terminam onde a ideia termina. Pedaço cortado no meio da frase vira meia resposta.

## Quando a palavra é exata, ela vale mais

Se a pessoa escreveu “parcelado”, “sábado” ou “estacionamento”, o trecho que contém aquela palavra sobe na frente de trechos só parecidos.

Busca por semelhança traz o que *parece* com a pergunta. Nem sempre é a resposta.

## Guarda o que a pessoa disse — nunca o que ele concluiu

“Prefere horários depois das 17h” entra: a pessoa disse, dá para conferir na conversa, e muda o que ele oferece amanhã.

“Não tem dinheiro” e “parece ansiosa” não entram. Ninguém disse isso — é entrelinha que vira rótulo colado na pessoa por anos.

## Sabe a hora de chamar gente

Dor, urgência, qualquer coisa clínica, reclamação e negociação de preço saem da máquina e viram tarefa de uma pessoa — com a conversa inteira junto.

## Dá para conversar com ele antes

Existe uma tela de teste: você escreve como se fosse o paciente e vê o que ele responderia — sem ninguém do outro lado.

## Escreve tudo o que fez, e por quê

Cada ação da IA fica registrada com data, motivo e o que ela sabia na hora. Dá para discordar depois — que é o que uma caixa-preta não permite.

## Por que isto não é “pedir para a IA se comportar”

Pedir no texto — “não dê diagnóstico” — é uma **sugestão** ao modelo, e um dia alguém escreve a mensagem que o convence. Aqui cada limite é uma trava de código, fora do modelo, que ele não tem como negociar. É a diferença entre uma recomendação e uma porta trancada.

O texto que governa a IA — o “manual” dela — não se edita direto no ar. Ele passa por um ciclo de quatro passos, e o terceiro é o que impede uma versão não testada de falar com paciente.

1

## Alguém edita — e isso vira rascunho

Editar nunca altera a versão que está no ar. Cria uma cópia nova, e essa cópia não fala com paciente nenhum.

2

## A prova roda sobre o rascunho

Uma bateria de casos difíceis passa pelo texto **novo**, não pelo que já estava publicado. Sem esse detalhe, a prova aprovaria uma versão e alguém publicaria outra — com toda a aparência de estar funcionando.

3

## Só uma prova aprovada libera publicar

E ela precisa ter avaliado **aquele** rascunho, não um parecido. É um portão, não um relatório que alguém olha e ignora.

4

## Publicado, o anterior vira histórico

Dá para ver o que mudou, quando, e voltar atrás.

**Quatro tipos de erro bloqueiam a publicação.** Não são questão de gosto: cada um nomeia um jeito de o sistema causar dano de verdade.

### Falou o que não podia

Deu opinião clínica, fechou preço ou prometeu resultado.

### Usou o que não tinha permissão

Conseguiu executar uma ação que a política daquela clínica negava.

### Misturou clínica

Conteúdo de uma unidade apareceu na conversa de outra.

### Respondeu o que era de gente

Uma conversa que exigia uma pessoa foi respondida pela máquina.

### Resposta seca não bloqueia

Tom e simpatia ficam de fora da lista: uma resposta dura é ruim, não é perigosa. Se tudo bloqueasse, ninguém passaria — e um portão que ninguém passa é um portão que alguém desliga.

Inteligência artificial cobra por uso. Um sistema que usa IA sem mostrar o preço é um sistema que um dia entrega uma fatura inesperada.

## Cada tarefa usa o modelo do tamanho dela

Conversar, classificar, supervisionar e buscar são trabalhos diferentes. Usar o modelo caro nos quatro é pagar preço de conversa em toda classificação.

## Teto de gasto que não dá para esquecer

O limite está na porta por onde toda chamada passa — confere **antes** de gastar. Conferir depois só serviria para descobrir o prejuízo.

## A clínica pode usar a conta dela

Se vocês tiverem conta própria de IA, o sistema usa a de vocês. A chave fica guardada cifrada e só é aberta no servidor, na hora do uso.

## Mostra o preço antes de apertar enviar

Uma campanha que diz “964 pessoas entram nesse filtro” e não diz **R\$ 301** está escondendo a metade que importa.

## Propaganda custa 9 vezes mais

O WhatsApp cobra por categoria. Uma reativação de 500 pessoas custa mais que o sistema inteiro rodando um mês.

Por isso a tela escreve **estimado**: quem decide a categoria final é o WhatsApp, não nós.

## Quando o fornecedor cai, ele corta a perna

Depois de algumas falhas seguidas, para de tentar por um tempo em vez de ficar preso esperando resposta que não vem.

Sem isso, a queda de um fornecedor derruba também as clínicas cujo fornecedor estava no ar.

## “É a gente ou é eles?”

Um painel responde isso às 19h de uma sexta: fornecedor fora do ar, chave vencida, teto estourado, botão de emergência acionado por engano, ou fila parada.

## Quatro números decidem se pode soltar

Quantas conversas viraram resposta; quantas foram para uma pessoa; quanto custou cada uma; e quais travas dispararam.

## Zero por cento de repasse é tão ruim quanto oitenta

Se a IA nunca chama uma pessoa, está respondendo o que não devia. Se chama em quase tudo, não está resolvendo nada e ainda custa. O sistema olha esse número dos dois lados — e nada de “nota de qualidade” dada pelo próprio modelo, que é elogio e não medição.

Hoje, para saber quem está na linha, alguém abre quatro telas e junta de cabeça. A ficha do CRC responde isso numa tela só — e cada número dela tem uma conta atrás, não um palpite.

## Quanto esse paciente já trouxe

E se isso é muito ou pouco **para esta clínica**: compara com o paciente do meio da sua base, não com uma média de mercado.

Média sobe com um caso de R\$ 40.000. A mediana não — por isso é a régua.

## Risco de sumir, com o porquê ao lado

Tempo sem aparecer, tratamento parado no meio, silêncio depois de uma tentativa de contato, retorno vencido. Cada fator aparece escrito.

Silêncio depois que a clínica falou pesa mais que ausência: a pessoa viu e não quis responder.

## Risco de faltar na consulta marcada

Do histórico dele e do comportamento da base — é o que alimenta a confirmação mais firme e a lista de espera.

## Enxerga a família no mesmo telefone

Mãe, filho e avó num número só é o caso normal, não a exceção. Mostra quem mais usa aquele contato antes de alguém escrever.

## Nunca junta dois pacientes só pelo nome

“Maria Silva” numa base de 8.000 são várias pessoas. Juntar prontuário de gente diferente é um estrago **sem volta**.

O nome serve para desempatar, jamais para casar.

## A linha do tempo inteira, num lugar

Consultas, mensagens, orçamentos, pagamentos, tentativas de contato e o que a IA fez — em ordem, com data.

## Melhor horário e melhor canal

Aprendido de quando essa pessoa costuma responder, e não de uma regra geral aplicada a todo mundo.

## As objeções, nas palavras dela

O que ela respondeu quando ouviu o valor — o texto original, não só a etiqueta que o sistema colocou.

## A ficha lê. Ela nunca escreve.

Nada nessa tela manda mensagem, marca consulta ou muda cadastro sozinho. Quem age é uma pessoa, ou uma automação que tem os próprios freios. É essa separação que permite mostrar tudo isso na tela sem medo.

Esta é a parte para quem é dono. Ela responde três perguntas: onde estamos, o que mudou desde ontem, e o que fazer com a distância entre o número de hoje e o que você quer.

## Meta vira plano, não vira cartaz

Você diz “quero 90% de ocupação até sexta”. Ele mede onde está, calcula a distância e quebra em ações que o próprio sistema sabe executar.

## Toda previsão sai com confiança do lado

E nasce **baixa**, porque ainda não existe histórico desta clínica. Plano que promete sem qualificar é o jeito mais rápido de você parar de acreditar nele.

## Se a meta exigir o que ele não faz, ele diz

Em vez de gerar uma ação vazia para preencher a tela. É a diferença entre um plano e um enfeite.

## O diagnóstico se mede sozinho

Ocupação e falta saem dos dados. A única coisa que você digita é quanto vale uma hora de cadeira.

## Compara a clínica com ela mesma

Este mês contra o anterior, cada dia da semana contra os outros, cada tratamento contra os demais, cada campanha contra as anteriores.

-----  
Abaixo de um volume mínimo ele não compara — dois casos não são tendência.

## Integração com estado medido, nunca declarado

Uma tela que diz “conectado” só porque alguém salvou uma senha mente exatamente no dia em que você foi conferir.

-----  
O estado que importa é **degradado**: respondeu semana passada, não responde desde ontem.

## Uma lista do que falta configurar

Em ordem, com o que já está pronto marcado. Sistema novo morre na primeira semana por falta disso.

## Mais de uma unidade, sem misturar

Cada pessoa enxerga só a unidade dela; o dono enxerga tudo. E o sistema avisa em texto claro o que cada escopo esconde.

## Nenhum número aqui é opinião

Todo indicador desta parte abre até a linha que o originou: qual paciente, qual consulta, qual pagamento. Painel que não abre é painel que ninguém confere — e painel que ninguém confere vira decoração.

Um sistema que age sozinho precisa de um volante. O CRC não tem um botão “ligado/desligado”: tem **seis níveis**, e você escolhe o nível separadamente para cada assunto.

0

## Desligado

Aquele assunto não existe para o sistema.

1

## Só observa

Ele olha, anota e não fala nada. É como se começa com tudo.

2

## Recomenda

Prepara a ação e deixa pronta. Uma pessoa lê e aperta enviar.

3

## Executa o de baixo risco

Confirmação e lembrete saem sozinhos. O resto continua esperando alguém.

4

## Executa e escala

Age sozinho e chama uma pessoa quando encontra o que não é dele.

5

## Piloto automático

Só faz sentido depois de meses de histórico — e continua com todos os freios.

### Dez assuntos, cada um com seu nível

Conversas, campanhas, retornos, agenda, tratamentos, cobrança, reputação, ligações, escrita no Dental Office e captação.

### A chave geral é sempre o teto

Nível 5 com o envio geral desligado continua não enviando nada. Vale sempre o **menor** dos dois.

### Botão de emergência

Para tudo, na hora, sem depender de ninguém estar acordado para autorizar.

### Cada pessoa vê o que é dela

Recepção, dentista, gerente e dono têm telas diferentes — verificadas no servidor, não só escondidas na tela.

Esta página vale mais que todas as outras juntas. Qualquer um vende o que um sistema faz; o que ele **recusa** a fazer é o que diz se dá para confiar nele dentro de uma clínica.

✕ **Não dá diagnóstico, nem opina sobre dor**

Qualquer pergunta clínica sai da máquina e vira tarefa de um dentista, com a conversa inteira anexada. Não é escolha de tom — é trava.

✕ **Não dá desconto, nem fecha preço**

Ele informa o que já está na tabela da clínica. Negociar é conversa de gente, e fica registrada com o nome de quem negociou.

✕ **Não escreve no prontuário**

Prontuário, faturamento e estoque continuam sendo do Dental Office. O CRC lê o que precisa e devolve trabalho pronto.

✕ **Não insiste com quem pediu para parar**

“Não quero mais receber” encerra tudo — inclusive cobrança. É o primeiro portão de todos, antes até de o texto ser examinado.

✕ **Não manda mensagem de madrugada**

Horário comercial, teto de contatos por período e intervalo mínimo entre um e outro. Vale para toda mensagem, inclusive as de cobrança.

✕ **Não promete resultado de tratamento**

Nem prazo de cura, nem garantia. Promessa em mensagem escrita é documento contra a clínica.

✕ **Não deixa uma clínica ver a outra**

A separação é feita pelo banco de dados, e não pela tela. Mesmo um erro de programação não consegue atravessar essa parede.

✕ **Não age fora do nível que você deu**

E não existe caminho alternativo: toda ação passa pelo mesmo portão, com o mesmo registro de data, motivo e o que o sistema sabia na hora.

**Se um limite barrar, não é silêncio**

Quando uma trava impede uma ação, isso aparece — na tela de saúde e no relatório da IA, com o nome do portão que barrou. O que não pode acontecer é o sistema parar por um motivo que ninguém consegue descobrir depois.

Tudo o que está nas páginas anteriores existe como programa: foi construído, testado, e as tabelas já estão no banco. O que falta não é construir — é **ligar com cuidado**, na ordem certa, para que o primeiro paciente a receber uma mensagem receba a mensagem certa.

1

## Construído e verificado

As funções deste documento estão implementadas, com mais de mil e setecentas verificações automáticas rodando a cada mudança. Nada aqui é promessa de futuro.

2

## Falta ligar os canais reais

WhatsApp oficial, Instagram, Google e o Dental Office precisam ser conectados com as contas da clínica. Enquanto não forem, o sistema roda vazio — e mostra isso na tela, em vez de fingir que está funcionando.

3

## Primeiras semanas em modo observador

Começa em “só observa” e “recomenda”: o sistema prepara tudo e uma pessoa aperta enviar. É assim que se descobre o que ele erra sem nenhum paciente pagar por isso.

4

## Soltar assunto por assunto

Confirmação e lembrete primeiro, que são os de menor risco. Campanha e cobrança por último. Cada assunto só sobe de nível depois de dar certo no anterior.

### O número que vai dizer se valeu

Não é “quantas mensagens o sistema mandou”. É **quanto de tratamento aconteceu por causa delas** — e isso o sistema já liga sozinho: da ação até a consulta, e da consulta até a produção. Se esse número não aparecer, ele vai ser o primeiro a mostrar.

# Como tudo se conecta

O MAPA DO SISTEMA

À esquerda, de onde a informação **entra**. No centro, o que o CRC **pensa**. À direita, o que **sai**. E embaixo, atravessando tudo, os freios — que valem para qualquer coisa que saia daqui.



WhatsApp, Instagram, Meta e Google são marcas de seus respectivos donos. Aparecem aqui para indicar com quais sistemas o CRC conversa.